ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

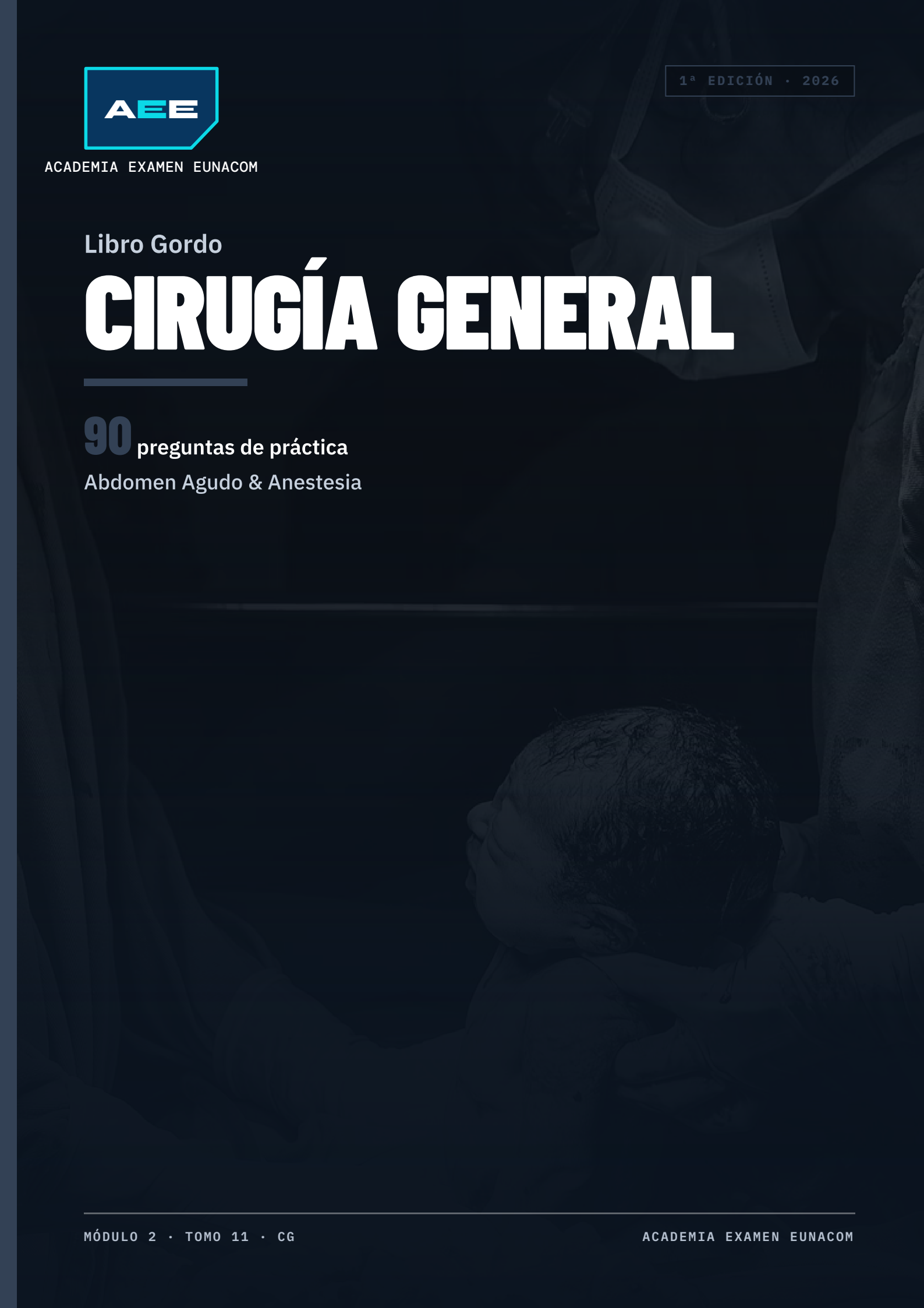
1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

CIRUGÍA GENERAL

90 preguntas de práctica

Abdomen Agudo & Anestesia



MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Cirugía General · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO					
4.01.1.002	Divertículos esofágicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.005	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q8	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.008	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q9	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.014	Pólipos de colon y recto	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.015	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q10	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.019	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.025	Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q7	Tomo 13 · 13.4 (Pág. 15)
4.01.1.028	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q12	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.030	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q13	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.031	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q14	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.033	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q15	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.035	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q16	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.037	Hidatidosis pulmonar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.039	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q17	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.040	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q18	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.044	Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q4	Tomo 11 · 11.19 (Pág. 34)
4.01.1.045	Enfermedad renovascular	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg:	—	Q5	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		Derivar			
4.01.1.049	Trombosis venosa profunda y tromboflebitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q6	Tomo 01 · 5.10 (Pág. 109)
BLOQUE 2: ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO					
4.01.1.001	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q24	Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5)
4.01.1.003	Divertículo de Meckel	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.006	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q22	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.007	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q32	Tomo 13 · 13.1 (Pág. 5)
4.01.1.009	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q33	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.011	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q25	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.016	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q26	Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30)
4.01.1.017	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q27	Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30)
4.01.1.018	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q34	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.01.1.020	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q28	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.021	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q23	Tomo 11 · 11.6 (Pág. 26)
4.01.1.022	Hidatidosis hepática	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.023	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q29	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.024	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q35	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.032	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q36	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.034	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q30	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Internas/Externas & Abscesos/Fístulas				
4.01.1.036	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q31	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.038	Nódulo pulmonar solitario	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
BLOQUE 3: POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)					
4.01.1.004	Acalasia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.026	Ictericia obstructiva	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 11 · C.13 (Pág. 30)
4.01.1.041	Síndromes mediastínicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.046	Insuficiencia cerebro vascular	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q40	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.050	Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q41	Tomo 11 · 11.19 (Pág. 34)
4.01.1.051	Pie diabético	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q42	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.053	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q52	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.01.1.054	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q53	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.055	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q51	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.056	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q54	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.058	Condilomas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q43	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.059	Onicocriptosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q44	Tomo 11 · 11.21 (Pág. 80)
4.01.1.060	Obesidad mórbida	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q45	Tomo 11 · 11.20 (Pág. 38)
4.01.2.002	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q46	Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20)
4.01.2.003	Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50	Tomo 11 · 11.5 (Pág. 21)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.2.005	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q49	Tomo 11 · 11.4 (Pág. 17)
4.01.2.006	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q47	Tomo 11 · 11.1 (Pág. 5)
4.01.2.007	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q48	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
BLOQUE 4: POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)					
4.01.1.012	Megacolon	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.027	Litiasis biliar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q56	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.042	Mesotelioma pleural	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q57	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.047	Insuficiencia arterial crónica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q58	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.052	Escaras	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q59	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.001	Esofagitis cáustica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q60	Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9)
4.01.2.008	Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q71	Tomo 11 · 11.3 (Pág. 13)
4.01.2.009	Prolapso rectal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q61	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.010	Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q68	Tomo 11 · 11.11 (Pág. 53)
4.01.2.011	Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70	Tomo 11 · 11.2 (Pág. 9)
4.01.2.012	Colangitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q62	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.013	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q65	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.015	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q72	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.016	Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66	Tomo 11 · 11.10 (Pág. 49)
4.01.2.017	Supuración pulmonar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q63	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.018	Hemoptisis masiva	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg:	—	Q64	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		Derivar			
4.01.2.020	Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q69	Tomo 12 · 12.6 (Pág. 24)
4.01.2.021	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q67	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
BLOQUE 5: PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS					
4.01.1.013	Enfermedad diverticular no complicada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15)
4.01.1.029	Pancreatitis crónica	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q74	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.043	Síndrome de ocupación pleural	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q75	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.048	Várices. Insuficiencia venosa crónica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q76	Tomo 11 · 11.19 (Pág. 34)
4.01.1.057	Cicatrices viciosas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q77	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.004	Hemorragia digestiva alta	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q78	Tomo 14 · 14.15 (Pág. 56)
4.01.2.014	Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q87	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.019	Perforación esofágica - Mediastinitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q79	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.022	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q89	Tomo 01 · 5.8 (Pág. 103)
4.01.2.023	Traumatismos vasculares	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q80	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.024	Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q86	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.025	Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q88	Tomo 11 · C.3 (Pág. 10)
4.01.2.026	Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q84	Tomo 11 · 11.13 (Pág. 61)
4.01.2.027	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q90	Tomo 11 · 11.9 (Pág. 45)
4.01.2.028	Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q85	Tomo 11 · 11.15 (Pág. 70)
4.01.2.029	Septicemia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q81	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.030	Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST &	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg:	—	Q83	Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Laparotomía de Urgencia	**Derivar**			
4.01.2.031	**Shock**	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q82	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Cirugía General · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.1.001	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q24	Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5)
4.01.1.002	Divertículos esofágicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.003	Divertículo de Meckel	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.004	Acalasia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.005	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q8	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.006	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q22	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.007	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q32	Tomo 13 · 13.1 (Pág. 5)
4.01.1.008	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q9	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.009	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q33	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.011	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q25	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.012	Megacolon	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.013	Enfermedad diverticular no complicada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15)
4.01.1.014	Pólipos de colon y recto	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.015	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q10	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.016	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q26	Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30)
4.01.1.017	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q27	Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.1.018	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q34	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.01.1.019	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.020	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q28	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.021	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q23	Tomo 11 · 11.6 (Pág. 26)
4.01.1.022	Hidatidosis hepática	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.023	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q29	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.024	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q35	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.025	Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q7	Tomo 13 · 13.4 (Pág. 15)
4.01.1.026	Ictericia obstructiva	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 11 · C.13 (Pág. 30)
4.01.1.027	Litiasis biliar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q56	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.028	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q12	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.029	Pancreatitis crónica	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q74	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.030	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q13	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.031	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q14	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.032	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q36	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.033	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q15	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.034	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q30	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.035	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q16	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.036	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg:	GES	Q31	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	**Completo**			
4.01.1.037	Hidatidosis pulmonar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.038	Nódulo pulmonar solitario	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.039	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q17	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.040	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q18	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.041	Síndromes mediastínicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.042	Mesotelioma pleural	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q57	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.043	Síndrome de ocupación pleural	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q75	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.044	Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q4	Tomo 11 · 11.19 (Pág. 34)
4.01.1.045	Enfermedad renovascular	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q5	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.046	Insuficiencia cerebro vascular	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q40	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.047	Insuficiencia arterial crónica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q58	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.048	Várices. Insuficiencia venosa crónica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q76	Tomo 11 · 11.19 (Pág. 34)
4.01.1.049	Trombosis venosa profunda y tromboflebitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q6	Tomo 01 · 5.10 (Pág. 109)
4.01.1.050	Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q41	Tomo 11 · 11.19 (Pág. 34)
4.01.1.051	Pie diabético	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q42	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.052	Escaras	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q59	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.053	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q52	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.01.1.054	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q53	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.1.055	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q51	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.056	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q54	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.057	Cicatrices viciosas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q77	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.058	Condilomas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q43	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.059	Onicocriptosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q44	Tomo 11 · 11.21 (Pág. 80)
4.01.1.060	Obesidad mórbida	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q45	Tomo 11 · 11.20 (Pág. 38)
4.01.2.001	Esofagitis cáustica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q60	Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9)
4.01.2.002	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q46	Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20)
4.01.2.003	Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50	Tomo 11 · 11.5 (Pág. 21)
4.01.2.004	Hemorragia digestiva alta	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q78	Tomo 14 · 14.15 (Pág. 56)
4.01.2.005	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q49	Tomo 11 · 11.4 (Pág. 17)
4.01.2.006	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q47	Tomo 11 · 11.1 (Pág. 5)
4.01.2.007	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q48	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.008	Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q71	Tomo 11 · 11.3 (Pág. 13)
4.01.2.009	Prolapso rectal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q61	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.010	Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q68	Tomo 11 · 11.11 (Pág. 53)
4.01.2.011	Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70	Tomo 11 · 11.2 (Pág. 9)
4.01.2.012	Colangitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q62	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.013	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q65	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.2.014	Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q87	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.015	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q72	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.016	Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66	Tomo 11 · 11.10 (Pág. 49)
4.01.2.017	Supuración pulmonar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q63	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.018	Hemoptisis masiva	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q64	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.019	Perforación esofágica - Mediastinitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q79	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.020	Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q69	Tomo 12 · 12.6 (Pág. 24)
4.01.2.021	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q67	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.022	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q89	Tomo 01 · 5.8 (Pág. 103)
4.01.2.023	Traumatismos vasculares	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q80	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.024	Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q86	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.025	Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q88	Tomo 11 · C.3 (Pág. 10)
4.01.2.026	Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q84	Tomo 11 · 11.13 (Pág. 61)
4.01.2.027	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q90	Tomo 11 · 11.9 (Pág. 45)
4.01.2.028	Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q85	Tomo 11 · 11.15 (Pág. 70)
4.01.2.029	Septicemia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q81	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.030	Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q83	Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7)
4.01.2.031	Shock	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q82	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

PREGUNTA 1 4.01.1.002

1. [ATENCIÓN PRIMARIA: Divertículos esofágicos · 4.01.1.002] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Divertículos esofágicos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 2 4.01.1.014

2. [ATENCIÓN PRIMARIA: Pólipos de colon y recto · 4.01.1.014] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Pólipos de colon y recto. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 4.01.1.037

3. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hidatidosis pulmonar · 4.01.1.037] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hidatidosis pulmonar. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 4 4.01.1.044

4. [ATENCIÓN PRIMARIA: Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea · 4.01.1.044] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 5 4.01.1.045

5. [ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedad renovascular · 4.01.1.045] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedad renovascular. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 6 4.01.1.049

6. Una paciente de 25 años, es operada de apendicitis aguda hace 24 horas, actualmente se encuentra muy decaída y con dificultad respiratoria. Al examen físico destaca pálida, frecuencia cardiaca de 110 por minuto y con presión arterial de 90/60. El diagnóstico más probable es:

A) Atelectasia

B) Reacción adversa a medicamentos

C) Tromboembolismo pulmonar

D) Infección de herida operatoria

E) Hemoperitoneo

PREGUNTA 7 4.01.1.025

7. [ATENCIÓN PRIMARIA: Colecistitis crónica · 4.01.1.025] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Colecistitis crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 8 4.01.1.005

8. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer del esofágo · 4.01.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer del esofágo. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 9 4.01.1.008

9. Un paciente de con antecedente de cáncer gástrico avanzado, con metástasis hepáticas múltiples y adenopatías perigástricas, consulta por cuadro de vómitos postprandiales intensos, que han ido en aumento y actualmente dificultan mucho la alimentación. Al examen físico está muy enflaquecido, con ausencia de grasa y con edema de extremidades inferiores. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Instalar sonda nasogástrica

B) Indicar nutrición parenteral total

C) Realizar radioterapia de urgencia

D) Realizar gastrectomía paliativa

E) Realizar derivación gastrointestinal

PREGUNTA 10 4.01.1.015

10. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer colorectal · 4.01.1.015] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer colorectal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 11 4.01.1.019

11. Un paciente de 45 años, diagnosticado de VIH, presenta sangrado rectal ocasional. Al examen físico, se observa lesión solevantada en los margenes anales, de 4 cm, que se introduce en el recto, sobrepasando la línea pectínea, con una con una ulceración central, con escaso sangrado. El diagnóstico más probable es:

A) Hemorroide externa trombosado
B) Condiloma acuminado
C) Sífilis
D) Cáncer epidermoide
E) Enfermedad de Cröhn

PREGUNTA 12 4.01.1.028

12. Una paciente de 60 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica electiva, por una colelitiasis. La biopsia es informada como presencia adenocarcinoma invasor en el fondo de la vesícula, subseroso. Se solicta un TAC de abdomen y pelvis con contraste, que no visualiza metástasis. ¿Cuál es la conducta?

A) Quimioterapia
B) Radioterapia
C) Cuidados paliativo
D) Control con TAC cada 3 meses
E) Colecistectomía radical

PREGUNTA 13 4.01.1.030

13. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares · 4.01.1.030] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 14 4.01.1.031

14. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer de páncreas · 4.01.1.031] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer de páncreas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 15 4.01.1.033

15. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer del tiroides · 4.01.1.033] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer del tiroides. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 16 4.01.1.035

16. Una paciente de 60 años presenta aumento de volumen en la axila derecha, de 4 cm de diámetro, indolora, de consistencia dura y adherida a planos profundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hidrosadenitis
B) Cáncer de mama
C) Cáncer de pulmón
D) Lipoma
E) Tuberculosis ganglionar

PREGUNTA 17 4.01.1.039

17. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer pulmonar · 4.01.1.039] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer pulmonar. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 18 4.01.1.040

18. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas · 4.01.1.040] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

BLOQUE 2 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

PREGUNTA 19 4.01.1.003

19. [ATENCIÓN PRIMARIA: Divertículo de Meckel · 4.01.1.003] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Divertículo de Meckel. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 20 4.01.1.022

20. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hidatidosis hepática · 4.01.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hidatidosis hepática. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 21 4.01.1.038

21. [ATENCIÓN PRIMARIA: Nódulo pulmonar solitario · 4.01.1.038] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Nódulo pulmonar solitario. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 22 4.01.1.006

22. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hernia hiatal · 4.01.1.006] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hernia hiatal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 23 4.01.1.021

23. Una paciente de 60 años consulta por aumento de volumen en la cara anterior del muslo, que en ocasiones es dolorosa y se asocia a náuseas y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen, por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Linfoma

B) Hernia inguinal

C) Adenopatía metastásica

D) Hernia femoral

E) Sarcoma de partes blandas

PREGUNTA 24 4.01.1.001

24. [ATENCIÓN PRIMARIA: Patología glándulas salivales · 4.01.1.001] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Patología glándulas salivales. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 25 4.01.1.011

25. [ATENCIÓN PRIMARIA: Fístulas del intestino delgado · 4.01.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Fístulas del intestino delgado. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 26 4.01.1.016

26. Paciente de 52 años con hemorroides externas trombosadas desde hace 6 horas, violáceas, protruidas, irreducibles y muy dolorosas. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Hemorroidectomía de urgencia

B) Trombectomía hemorroidal bajo anestesia local

C) Ligadura con banda elástica

D) Manejo médico conservador con analgesia y baños de asiento

E) Escleroterapia

PREGUNTA 27 4.01.1.017

27. **Un hombre de 60 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra baja. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de 4 cm de diámetro, dolorosa a la palpación, fluctuante, con signos inflamatorios. El tratamiento más adecuado es:**

A) Curación plana
B) Drenaje quirúrgico
C) Antibióticos orales
D) Punción y drenaje
E) Analgésicos

PREGUNTA 28 4.01.1.020

28. **Un paciente de 54 años consulta por dolor anal, que se presenta al defecar, persis- tiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas ocasiones además ha presentado sangre en las deposiciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemorroide externo trombosado
B) Cáncer de recto
C) Fisura anal
D) Fístula anal
E) Absceso perianal

PREGUNTA 29 4.01.1.023

29. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Quistes y abscesos hepáticos · 4.01.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Quistes y abscesos hepáticos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 30 4.01.1.034

30. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Patología benigna del tiroides · 4.01.1.034] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Patología benigna del tiroides. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 31 4.01.1.036

31. **Un paciente de 35 años presenta un nódulo mamario, desde hace 8 meses. Su ecografía mamaria muestra un tumor de aspecto sólido, bordes bien delimitados, sin refuerzo posterior y con un índice ultrasonográfico Birrads 3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Mastopatía fibroquística
B) Papiloma ductal
C) Fibroadenoma
D) Tumor phylloides
E) Carcinoma ductal

PREGUNTA 32 4.01.1.007

32. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores gástricos benignos · 4.01.1.007] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores gástricos benignos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 33 4.01.1.009

33. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores del intestino delgado · 4.01.1.009] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores del intestino delgado. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 34 4.01.1.018

34. **Una paciente de 20 años presenta aumento de volumen eritematoso y doloroso, en la zona interglútea, ubicado a dos centímetros de la línea media, sobre el coxis. Al examen físico, se observa aumento de volumen de 5 cm, doloroso, con presencia de dos orificios negros en la piel, cerca de la lesión. El diagnóstico más probable es:**

A) Linfoma

B) Sarcoma

C) Quiste pilonidal

D) Absceso anorrectal

E) Lipoma

PREGUNTA 35 4.01.1.024

35. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores hepáticos · 4.01.1.024] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores hepáticos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 36 4.01.1.032

36. **Un paciente de 25 años de edad, sin patologías previas, presenta desde hace 4 años aumento de volumen cervical lateral, que ha ido creciendo. Al examen se constata una masa palpable, de 3 cm, en la zona lateral del cuello, de ubicación submandibular. Se solicita una ecografía cervical, que muestra un nódulo hipoecogénico, de bordes bien delimitados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Nódulo tiroideo

B) Quiste branquial

C) Quiste tirogloso

D) Linfadenopatía tuberculosa

E) Tumor de glándula salival secundaria

BLOQUE 3 POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

PREGUNTA 37 4.01.1.004

37. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Acalasia · 4.01.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Acalasia. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 4.01.1.026

38. **Paciente que empieza con ictericia 7 días post colecistectomía:**

A) Litiasis en vía biliar común

B) Lesión vía biliar iatrogénica

C) Ninguna de las anteriores es correcta

D) Todas las anteriores son correctas

E) No se dispone de información suficiente

PREGUNTA 39 4.01.1.041

39. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndromes mediastínicos · 4.01.1.041] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndromes mediastínicos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 40 4.01.1.046

40. [ATENCIÓN PRIMARIA: Insuficiencia cerebro vascular · 4.01.1.046] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Insuficiencia cerebro vascular. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 41 4.01.1.050

41. Un paciente de 58 años, con antecedente de várices en ambas piernas, de gran tamaño, consulta porque hace dos semanas sufrió un pequeño trauma en su extremidad inferior izquierda, evolucionando con una lesión ulcerada que ha aumentado de tamaño, hasta alcanzar 1,5 cm y que se ubica a 2 cm del maléolo interno. Al examen físico, se aprecia oscurecimiento de la piel circundante, más la presencia de las várices descritas. ¿Cuál es la etiología más probable de su lesión?

A) Infecciosa
B) Isquémica
C) Venosa
D) Neuropática
E) Por presión

PREGUNTA 42 4.01.1.051

42. Un paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, presenta desde hace unas semanas úlcera en zona plantar derecha, asociado a secreción purulenta. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones y afebril, se aprecia úlcera bajo la articulación metatarsofalángica del primer ortejo derecho, con compromiso de piel, tejido subcutáneo y tendones, sin signos de compromiso óseo ni articular. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Antibióticos vía oral y curaciones ambulatorias
B) Angiografía
C) Amputación abierta
D) Amputación cerrada
E) Antibióticos endovenosos y debridación quirúrgica

PREGUNTA 43 4.01.1.058

43. [ATENCIÓN PRIMARIA: Condilomas · 4.01.1.058] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Condilomas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 44 4.01.1.059

44. [ATENCIÓN PRIMARIA: Onicocriptosis · 4.01.1.059] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Onicocriptosis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 45 4.01.1.060

45. **Una paciente de 35 años, con antecedente de bypass gástrico hace un año, presenta crisis de mareos, palpitaciones, malestar general y diarrea, que aparecen después de comer. El diagnóstico más probable es:**

A) Hipoglicemias reactivas
B) Síndrome de dumping
C) Hernia del espacio de Petersen
D) Estenosis de la anastomosis
E) Déficit de vitamina B12

PREGUNTA 46 4.01.2.002

46. **[URGENCIA: Abdomen agudo · 4.01.2.002] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Abdomen agudo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 47 4.01.2.006

47. **Niña de 7 años de edad, quien consulta por cuadro de 12 horas de evolución, caracterizada por fiebre y dolor hipogástrico. Al examen físico tiene temperatura: 38,7 grados, FC: 100x', PA: 100/60, dolor a la palpación de hipogastrio, con signo de Blumberg positivo y resistencia en la pared abdominal. Exámenes de laboratorio; 18.000 glóbulos blancos. Sedimento urinario muestra 20 leucocitos por campo. Proteína C reactiva: 15. El diagnóstico más probable es:**

A) Pielonefritis aguda
B) Apendicitis aguda
C) ITU baja
D) Torsión ovárica
E) Plastrón apendicular

PREGUNTA 48 4.01.2.007

48. **Un paciente de 66 años, hipertenso, cardiópata, en tratamiento anticoagulante por una fibrilación auricular crónica, consulta por dolor abdominal brusco, muy intenso, de 6 horas de evolución. Al examen físico presenta ritmo irregular en 2 tiempos y abdo- men doloroso a la palpación, con signos peritoneales difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trombosis de la vena mesentérica
B) Hemoperitoneo
C) Úlcera péptica perforada
D) Embolia mesentérica
E) Aneurisma aórtico abdominal roto

PREGUNTA 49 4.01.2.005

49. **Un paciente de 60 años, que hace tres años se habría realizado una colecistectomía con coledocostomía, consulta por cuadro de dolor abdominal tipo cólico intenso, asocia- do a vómitos alimentarios. No ha podido eliminar gases. Al examen físico presenta do- lor difuso a la palpación abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y to- nalidad, con blumberg presente. El diagnóstico más probable es:**

A) Obstrucción intestinal
B) Trombosis venosa mesentérica
C) Embolia mesenterica
D) Pancreatitis
E) Diverticulitis

PREGUNTA 50 4.01.2.003

50. **Una paciente de 43 años, multípara, presenta dolor abdominal difuso, intenso y vómitos, con marcado meteorismo. Al examen, tiene FC: 110x', PA: 100/60 mmHg y al examen abdominal se observa cicatriz de cesárea Pfannestiel, y se palpa abdomen muy doloroso tanto a la palpación superficial como profunda, con distensión de la pared abdominal, pérdida de la matidez hepática a la percusión y abolición de los ruidos hidroaéreos a la auscultación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Obstrucción intestinal
B) Pancreatitis aguda
C) Perforación intestinal
D) Megacolon
E) Embolia mesentérica

PREGUNTA 51 4.01.1.055

51. **Un paciente de 28 años tiene un quiste epidérmico en el cuello y consulta porque ahora aumentó de volumen y se ha vuelto doloroso y eritematoso. Al examen físico se lo aprecia según la imagen: FOTO (absceso en el cuello, con algo de eritema alrededor y se ve de aspecto amarillo). La conducta más adecuada es:**

A) Observar evolución
B) Indicar corticoides tópicos
C) Indicar antibióticos más drenaje quirúrgico
D) Realizar resección quirúrgica del quiste
E) Puncionar la lesión

PREGUNTA 52 4.01.1.053

52. **Joven con aumento de volumen blando no adherido en muslo derecho (?era en la espalda), estudio inicial:**

A) Ecografía de piel y partes blandas (REPETIDA DEL 2023)
B) Psoriasis
C) Dermatitis atópica
D) Dermatitis de contacto
E) Liquen plano

PREGUNTA 53 4.01.1.054

53. **Un paciente de 18 años, consulta porque desde hace un año presenta aumento de volumen progresivo en la cara anterior del muslo derecho, que recientemente se ha vuelto dolorosa. Al examen físico se palpa una masa de 10 cm de diámetro, de consistencia dura, no pétrea, sin afectación de la piel. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar resección y biopsia
B) Observar evolución
C) Solicitar ecografía de partes blandas
D) Solicitar radiografía de fémur
E) Realizar punción y drenaje

PREGUNTA 54 4.01.1.056

54. **Un paciente de 52 años, con una gran cicatriz de una quemadura antigua, de gran tamaño, en el muslo derecho, que cicatrizó por segunda intención, refiere que, desde hace dos años, presenta una úlcera en relación a la cicatriz. Al examen físico se observa una úlcera de 2 cm en medio de la cicatriz. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tratamiento con nitrógeno líquido
B) Aseo quirúrgico
C) Resección amplia
D) Biopsia incisional
E) Curaciones con povidona y suero fisiológico

BLOQUE 4 POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

PREGUNTA 55 4.01.1.012

55. **Un recién nacido de término, de 5 días de vida, aún no ha eliminado meconio. Además, presenta irritabilidad, vómitos postprandiales frecuentes y distensión abdominal. Al examen tiene ano permeable y se realiza un enema baritado, que muestra colon proximal dilatado y colon distal estrecho. El examen más adecuado para confirmar el diagnóstico es:**

A) TAC abdominal
B) Colonoscopía
C) Test del sudor
D) Biopsia por succión
E) Cariograma

PREGUNTA 56 4.01.1.027

56. **Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta episodios de dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente luego de algunos minutos. Se realiza una ecografía, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): El diagnóstico más probable es:**

A) Colelitiasis
B) Coledocolitiasis
C) Colecistitis crónica
D) Cáncer de vesícula
E) Colecistitis aguda

PREGUNTA 57 4.01.1.042

57. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Mesotelioma pleural · 4.01.1.042] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Mesotelioma pleural. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 58 4.01.1.047

58. **Diabético fumador con dolor en pantorrillas al caminar 120 metros, ausencia de reflejos patelares, hipoestesia y pulsos pedios débiles. ¿Cuál es el examen de elección?**

A) Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa
B) AngioTAC de extremidades inferiores
C) Arteriografía de extremidades inferiores
D) Doppler venoso de extremidades inferiores
E) Índice tobillo-brazo (ITB)

PREGUNTA 59 4.01.1.052

59. [ATENCIÓN PRIMARIA: Escaras · 4.01.1.052] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Escaras. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 60 4.01.2.001

60. [URGENCIA: Esofagitis cáustica · 4.01.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Esofagitis cáustica. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 61 4.01.2.009

61. [URGENCIA: Prolapso rectal · 4.01.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Prolapso rectal. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 62 4.01.2.012

62. [URGENCIA: Colangitis · 4.01.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Colangitis. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 63 4.01.2.017

63. [URGENCIA: Supuración pulmonar · 4.01.2.017] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Supuración pulmonar. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 64 4.01.2.018

64. [URGENCIA: Hemoptisis masiva · 4.01.2.018] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hemoptisis masiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 65 4.01.2.013

65. [URGENCIA: Pancreatitis aguda · 4.01.2.013] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Pancreatitis aguda. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 66 4.01.2.016

66. Un paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, en el lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico y presenta disminución del murmullo pulmonar, asociado a hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Pedir radiografía de tórax
B) Pedir resonancia magnética de tórax
C) Instalar un tubo pleural
D) Solicitar TAC de tórax
E) Realizar videotoracoscopía

PREGUNTA 67 4.01.2.021

67. [URGENCIA: Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos · 4.01.2.021] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 68 4.01.2.010

68. Un paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y examen abdominal sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. Se realiza exploración digital de la herida, con anestesia local, objetivándose laceración del peritoneo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar lavado peritoneal diagnóstico
B) Realizar ecografía fast
C) Suturar la herida
D) Solicitar TAC abdominal
E) Realizar laparoscopía exploradora

PREGUNTA 69 4.01.2.020

69. [URGENCIA: Traumatismo raquimedular · 4.01.2.020] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismo raquimedular. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 70 4.01.2.011

70. Mujer de 55 años con colecistitis aguda de 48 horas de evolución. Estable hemodinámicamente, fiebre 38°C, leucocitos 14.000. ¿Cuál es el manejo quirúrgico más adecuado?

A) Colecistectomía laparoscópica precoz (dentro de 72h)
B) Cirugía electiva en 6 semanas
C) Drenaje percutáneo y cirugía diferida
D) Solo ATB EV y observación
E) Colecistostomía abierta de urgencia

PREGUNTA 71 4.01.2.008

71. Un paciente de 73 años presenta un cuadro de 2 días de dolor abdominal, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signos de irritación peritoneal en la zona. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Apendicitis aguda
B) Cáncer de colon
C) Obstrucción intestinal
D) Diverticulitis aguda
E) Hernia inguinal complicada

PREGUNTA 72 4.01.2.015

72. **[URGENCIA: Trauma maxilofacial · 4.01.2.015] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Trauma maxilofacial. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

BLOQUE 5 PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

PREGUNTA 73 4.01.1.013

73. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedad diverticular no complicada · 4.01.1.013] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedad diverticular no complicada. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 4.01.1.029

74. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Pancreatitis crónica · 4.01.1.029] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Pancreatitis crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 75 4.01.1.043

75. **Un paciente de 19 años consulta por dolor torácico derecho, de 24 horas de evolución, que aumenta con la inspiración. Al examen físico, se aprecia disminución del murmullo pulmonar en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: Foto 13 (https://imgur.com/gallery/U6p0b/comment/113820836) (La foto fue ennegrecida, para que se pareciera a las del Eunacom real, impreso). ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Control radiológico en 24 horas

B) Solicitar TAC de tórax

C) Realizar cirugía abierta

D) Drenaje con tubo pleural

E) Videotoracoscopía

PREGUNTA 76 4.01.1.048

76. **Mujer de 45 años con várices en extremidades inferiores bilaterales, sin úlceras ni tromboflebitis. Sin otros antecedentes mórbidos. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Anticoagulación oral
B) Flebectomía inmediata
C) Escleroterapia de urgencia
D) Medidas conservadoras: dieta, ejercicio y medias compresivas
E) Derivación vascular urgente

PREGUNTA 77 4.01.1.057

77. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Cicatrices viciosas · 4.01.1.057] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cicatrices viciosas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 78 4.01.2.004

78. **[URGENCIA: Hemorragia digestiva alta · 4.01.2.004] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hemorragia digestiva alta. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 79 4.01.2.019

79. **Paciente de 43 años, con historia de epigastralgia desde hace 3 semanas sin otros síntomas, como parte del estudio de su patología se realiza endoscopía digestiva alta que muestra gastritis erosiva, sin presencia de úlcera péptica activa y con test de ureasa positivo, por este motivo se indica tratamiento erradicador del helicobacter pylori. Tres horas luego del procedimiento, evoluciona con dolor toráxico irradiado a hombro derecho y sensación febril. El examen de elección para confirmar el diagnóstico en este caso es:**

A) Radiografía de tórax
B) Repetir endoscopía
C) Tomografía axial computada de tórax
D) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
E) Electrocardiograma

PREGUNTA 80 4.01.2.023

80. **[URGENCIA: Traumatismos vasculares · 4.01.2.023] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismos vasculares. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 81 4.01.2.029

81. **[URGENCIA: Septicemia · 4.01.2.029] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Septicemia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 82 4.01.2.031

82. [URGENCIA: Shock · 4.01.2.031] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Shock. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 83 4.01.2.030

83. [URGENCIA: Paro cardiorespiratorio · 4.01.2.030] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Paro cardiorespiratorio. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 84 4.01.2.026

84. Niño con quemadura en palmas y dedos, eritema importante y ampollas, inquieto e irritable en urgencias. ¿Cuál es la conducta inicial?

A) Aplicar apósitos de plata y hospitalizar

B) Enfriar con agua fría y cubrir con gasa estéril

C) Indicar analgesia endovenosa

D) Hospitalizar para manejo de quemaduras

E) Debridación bajo anestesia general inmediata

PREGUNTA 85 4.01.2.028

85. Una mujer de 28 años, trabajadora del área de la salud, es encontrada inconsciente por su pareja en el baño de su casa. Al examen físico, está comprometida de conciencia, tiene frecuencia cardíaca de 60 por minuto, frecuencia respiratoria de 8 por minuto y se observan pupilas mióticas, sin focalidad neurológica. ¿Qué tipo de fármaco es el responsable del cuadro de intoxicación de esta paciente?

A) Benzodiacepinas

B) Barbitúricos

C) Antidepresivos tricíclicos

D) Opioides

E) Hipoglicemiantes

PREGUNTA 86 4.01.2.024

86. Un paciente, apendictomizado hace 6 horas evoluciona con malestar general y dolor abdominal. Su pulso es regular a 120 latidos por minuto y su presión arterial es 90/50 mmHg. En el examen abdominal presenta dolor y signos peritoneales en el hemiabdomen inferior. El diagnóstico más probable es:

A) Hemoperitoneo

B) Evisceración

C) Trombosis de la vena porta

D) Dehiscencia de la base apendicular

E) Tromboembolismo pulmonar masivo

PREGUNTA 87 4.01.2.014

87. Un niño de 6 años sufre un accidente en el campo, golpeándose con un palo en la cabeza y resultando con una herida supraciliar derecha de 5 cm de longitud. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Afrontamiento con cianoacrilato

B) Afrontamiento con tela adhesiva

C) Sutura con punto separado

D) Sutura intradérmica

E) Dejar que cure por segunda intención

PREGUNTA 88 4.01.2.025

88. [URGENCIA: Heridas y contusiones menores · 4.01.2.025] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Heridas y contusiones menores. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 89 4.01.2.022

89. **Un paciente de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertesión ar- terial, consulta por dolor abdominal de tipo inespecífico, de 2 meses de evolución, sin otros síntomas. En su examen físico se palpa un tumor abdominal de 4 a 5 cm de diámetro, en la zona umbilical, pulsátil, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trombosis mesentérica

B) Tumor de colon

C) Tumor de páncreas

D) Disección aórtica

E) Aneurisma aórtico abdominal

PREGUNTA 90 4.01.2.027

90. **[URGENCIA: Trauma · 4.01.2.027] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Trauma. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 **Respuesta: A** Divertículos esofágicos — 4.01.1.002 — Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Divertículos esofágicos" (4.01.1.002), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 2 **Respuesta: A** Pólipos de colon y recto — 4.01.1.014 — Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Pólipos de colon y recto" (4.01.1.014), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 3 **Respuesta: A** Hidatidosis pulmonar — 4.01.1.037 — Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hidatidosis pulmonar" (4.01.1.037), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 4 **Respuesta: A**

Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea — 4.01.1.044 — Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea" (4.01.1.044), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 5 **Respuesta: A** Enfermedad renovascular — 4.01.1.045 — Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedad renovascular" (4.01.1.045), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 6 **Respuesta: C**

Trombosis venosa profunda y tromboflebitis — 4.01.1.049 — Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por ser postQx es TEP y por el compromiso HDN es masivo probblemente

PREGUNTA 7 **Respuesta: A**

4.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Colecistitis crónica" (4.01.1.025), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 8 **Respuesta: A**

4.01.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer del esofágo" (4.01.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 9 **Respuesta: E**

4.01.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

La derivación gastroyeyunal es menos agresiva que la hgastrectomía y permite retablecer el tránsito gastrointestinal.

PREGUNTA 10 **Respuesta: A**

4.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer colorectal" (4.01.1.015), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 11 **Respuesta: D**

4.01.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

Es un cáncer de recto, que aumenta el riesgo en el paciente VIH, en especial con VPH de alto riesgo (serotipos 16 y 18).

PREGUNTA 12 **Respuesta: E**

4.01.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

Lo correcto es hacer una cirugía abierta, con cuña hepática y linfadenectomía y no una colecistectomía radical, ya que la vesícula ya se extirpó. Sin embargo, de las alternativas que había, era la más aceptable.

PREGUNTA 13 **Respuesta: A**

4.01.1.030 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares" (4.01.1.030), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 14 **Respuesta: A**

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

4.01.1.031 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer de páncreas" (4.01.1.031), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 15 **Respuesta: A**

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

4.01.1.033 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer del tiroides" (4.01.1.033), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 16 **Respuesta: B**

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

4.01.1.035 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El cáncer de mama es el que da metástasis gangionares a la axila con mayor frecuencia. Que sea indolora descarta hidrosadenitis. Lipoma es blando. TBC ganglionar es rara y suele tener una clínica más inflamatoria, con fistulización: sale caseum.

PREGUNTA 17 **Respuesta: A**

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

4.01.1.039 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer pulmonar" (4.01.1.039), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 18 **Respuesta: A**

Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones

4.01.1.040 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas" (4.01.1.040), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

BLOQUE 2 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: A** **Divertículo de Meckel** 4.01.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Divertículo de Meckel" (4.01.1.003), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 20 **Respuesta: A** **Hidatidosis hepática** 4.01.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hidatidosis hepática" (4.01.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 21 **Respuesta: A** **Nódulo pulmonar solitario** 4.01.1.038 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Nódulo pulmonar solitario" (4.01.1.038), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 22 **Respuesta: A**

Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones

4.01.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hernia hiatal" (4.01.1.006), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 23 **Respuesta: D**

Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones

4.01.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es una hernia femoral clásica (bajo el ligamento inguinal). Es más frecuente en mujeres.

PREGUNTA 24 **Respuesta: A**

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

4.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Patología glándulas salivales" (4.01.1.001), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 25 **Respuesta: A**

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

4.01.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Fístulas del intestino delgado" (4.01.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 26 **Respuesta: B**

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

4.01.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Hemorroides externas trombosadas en primeras 72h: trombectomía bajo anestesia local alivia el dolor en forma inmediata. Después de 72h, el manejo es conservador pues el trombo se reabsorbe.

PREGUNTA 27 **Respuesta: B**

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

4.01.1.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Probable absceso perianal. Debe ser drenado en pabellón.

PREGUNTA 28 **Respuesta: C**

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

4.01.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Fisura anal clásica.

PREGUNTA 29 **Respuesta: A**

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

4.01.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Quistes y abscesos hepáticos" (4.01.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 30 **Respuesta: A**

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

4.01.1.034 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Patología benigna del tiroides" (4.01.1.034), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 31 **Respuesta: C**

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

4.01.1.036 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es un fibroadenoma clásico. Se sigue con ecografía cada 6 meses por 2 años. Se ve sólido, hipoecogénico, con bordes bien definidos, habitualmente con forma oval y orientación horizontal. Suele no tener sombra ni refuerzo posterior.

PREGUNTA 32 **Respuesta: A**

Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

4.01.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores gástricos benignos" (4.01.1.007), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 33 **Respuesta: A**

Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

4.01.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores del intestino delgado" (4.01.1.009), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 34 **Respuesta: C**

Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

4.01.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 43). Evalúa el manejo clínico de Enfermedades del seno pilonidal según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 35 **Respuesta: A**

4.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores hepáticos" (4.01.1.024), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 36 **Respuesta: B**

4.01.1.032 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

Es un quiste branquial clásico (zona lateral del cuello y crecimiento muy lento). No puede ser nódulo tiroideo, por la ubicación (la tiroides está en la zona media inferior del cuello). Tampoco un quiste del conducto tirogloso, porque este es de la línea media. La adenopatía tuberculosa o escrófula crece más rápido y suele fistulizarse, dando salida a material caseoso.

BLOQUE 3 POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS) · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A** **Acalasia** 4.01.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Acalasia" (4.01.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 38 **Respuesta: B** **Ictericia obstructiva** 4.01.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 161). Evalúa el manejo clínico de Ictericia obstructiva según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 39 **Respuesta: A** **Síndromes mediastínicos** 4.01.1.041 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndromes mediastínicos" (4.01.1.041), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 40 **Respuesta: A** **Insuficiencia cerebro vascular** 4.01.1.046 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Insuficiencia cerebro vascular" (4.01.1.046), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 41 **Respuesta: C**

4.01.1.050 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)

Úlcera venosa: Las úlceras venosas suelen ser poco dolorosas o incluso indoloras. Se ubican generalmente en el maléolo interno y se asocian al síndrome postflebítico, que se caracteriza por hiperpigmentación de la piel. En contraste, las úlceras arteriales son dolorosas y se ubican con mayor frecuencia en el maléolo externo, los ortejos o los talones. El fondo de las úlceras arteriales es isquémico, de color pálido o blanco, mientras que el fondo de las úlceras venosas es hiperémico y violáceo.

PREGUNTA 42 **Respuesta: E** Pie diabético 4.01.1.051 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una fasceítis necrotizante, sin compromiso óseo (no amputar). Si tuviera la osteomielitis, se amputa el pie diabético.

PREGUNTA 43 **Respuesta: A** Condilomas 4.01.1.058 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Condilomas" (4.01.1.058), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 44 **Respuesta: A** Onicocriptosis 4.01.1.059 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Onicocriptosis" (4.01.1.059), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 45 **Respuesta: B** Obesidad mórbida 4.01.1.060 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene un síndrome de dumping clásico (aprender dicha clínica), frecuente complicación de un by-pass gástrico. Se caracteriza por síntomas disautonómicos, que pueden ser muy similares a una hipoglicemia, por lo que siempre se debe solicitar HGT para descartarla. Sin embargo, la diarrea no calza con hipoglicemia, sino solo con dumping.

PREGUNTA 46 **Respuesta: A**

Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Abdomen agudo" como urgencia clínica (4.01.2.002), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 47 **Respuesta: B**

Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía

4.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una apendicitis clásica.

PREGUNTA 48 **Respuesta: D**

Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía

4.01.2.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una embolia mesentérica clásica, por la FA. Sin embargo, suele cursar sin signos peritoneales al inicio, pero había pasado ya mucho tiempo, por lo que sí aparecen di- chos signos.

PREGUNTA 49 **Respuesta: A**

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

4.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una obstrucción intestinal clásica, probablemente por bridas (antecedente de cirugía).

PREGUNTA 50 **Respuesta: C**

Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)

4.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La pérdida de la matidez hepática sugiere un neumoperitoneo, secundario a una perforación. También tiene clínica de la peritonitis secundaria: abolición de RHA, dolor intenso.

PREGUNTA 51 **Respuesta: C**

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

4.01.1.055 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene un quiste epidérmico abscedado, lo que se trata con antibióticos (antiestafilocócicos: ej. cloxacilina) más drenaje quirúrgico. Eventualmente, el quiste sí se debe resecar, pero no mientras está infectado.

PREGUNTA 52 **Respuesta: A**

Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

4.01.1.053 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 79). Evalúa el manejo clínico de Tumores benignos de partes blandas según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 53 **Respuesta: C**

Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

4.01.1.054 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un probable sarcoma de partes blandas. Debe estudiarse con resonancia magnética nuclear, como examen de elección, para determinar el grado de invasión, antes de definir qué tipo de cirugía se le hará. Como no aparecía en las opciones, lo más razonable es hacer la ecografía, porque al menos es suficiente para distinguir entre un tumor benigno y uno maligno. Luego sí se hará la resección y biopsia.

PREGUNTA 54 **Respuesta: D**

Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

4.01.1.056 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una úlcera de Majorlin, que es un tipo de carcinoma espinocelular de muy lento crecimiento, que aparece en cicatrices de grandes quemaduras. Su diagnóstico es la biopsia incisional o con una biopsia "punch" y luego de confirmar la histología, se procede a la excisión completa y manejo oncológico. En ocasiones, el carcinoma solo está en una zona del borde de la úlcera, por lo que se recomienda varias biopsias incisionales. Si no lo sabían, pues ahora ya lo saben y sea como sea, tenía "pinta" de cáncer, así que a biopsiarlo.

BLOQUE 4 POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS) · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: D** **Megacolon** 4.01.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Se sospecha una enfermedad de Hirschsprüng, que se diagnostica con la biopsia intestinal, que muestra aganglionosis del plexo submucoso o mientérico, en el segmento afectado.

PREGUNTA 56 **Respuesta: A** **Litiasis biliar** 4.01.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una imagen de cálculos con la sombra acústica clásica. Se debe programar cirugía electiva.

PREGUNTA 57 **Respuesta: A** **Mesotelioma pleural** 4.01.1.042 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Mesotelioma pleural" (4.01.1.042), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 58 **Respuesta: E** **Insuficiencia arterial crónica** `4.01.1.047` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

Índice tobillo-brazo (ITB)

PREGUNTA 59 **Respuesta: A** **Escaras** `4.01.1.052` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo`

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Escaras" (4.01.1.052), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 60 **Respuesta: A** **Esofagitis cáustica** `4.01.2.001` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Esofagitis cáustica" como urgencia clínica (4.01.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A** **Prolapso rectal** `4.01.2.009` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Prolapso rectal" como urgencia clínica (4.01.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 62 **Respuesta: A** **Colangitis** `4.01.2.012` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Colangitis" como urgencia clínica (4.01.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 63 **Respuesta: A** **Supuración pulmonar** `4.01.2.017` `Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Supuración pulmonar" como urgencia clínica (4.01.2.017), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 64 **Respuesta: A** **Hemoptisis masiva** `4.01.2.018` `Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hemoptisis masiva" como urgencia clínica (4.01.2.018), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 65 **Respuesta: A**

`4.01.2.013` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Pancreatitis aguda" como urgencia clínica (4.01.2.013), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 66 **Respuesta: A**

4.01.2.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante

Tiene una probable herida penetrante de tórax, con un neumotórax traumático. No tiene clínica de neumotórax a tensión, así que no hay que puncionar el segundo espacio intercostal. Lo primero siempre es pedir la radiografía de tórax, tanto para ver el grado del neumotórax, como para descartar otras complicaciones (ej: hemotórax).

PREGUNTA 67 **Respuesta: A**

4.01.2.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos" como urgencia clínica (4.01.2.021), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 68 **Respuesta: E**

4.01.2.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia

Tiene una herida penetrante abdominal (lacera el peritoneo). La mayoría de los autores recomienda explorar, idealmente por laparoscopía. De todos modos algunos recomiendan hacer EcoFast si está en tan buenas condiciones y tiene buena evolución (como es este caso). No es un tema cerrado, sino controvertido.

PREGUNTA 69 **Respuesta: A**

4.01.2.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismo raquimedular" como urgencia clínica (4.01.2.020), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 70 **Respuesta: A**

4.01.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap

Colecistitis aguda no complicada: colecistectomía laparoscópica precoz (<72h del diagnóstico) es superior al manejo diferido. Menor complicaciones, estadía hospitalaria y conversión a cirugía abierta.

PREGUNTA 71 **Respuesta: D**

4.01.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx

Cuadro clásico

PREGUNTA 72 **Respuesta: A**

4.01.2.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Trauma maxilofacial" como urgencia clínica (4.01.2.015), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 73 **Respuesta: A**

Enfermedad diverticular no complicada

4.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedad diverticular no complicada" (4.01.1.013), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 74 **Respuesta: A** **Pancreatitis crónica**

4.01.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Pancreatitis crónica" (4.01.1.029), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 75 **Respuesta: D** **Síndrome de ocupación pleural**

4.01.1.043 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por la clínica era un neumotórax. La radiografía era muy oscura, pero con imaginación y paciencia, se veía el neumotórax derecho (acá se ve más que en el real). Por ser mayor a 15%, se trata con tubo pleural.

PREGUNTA 76 **Respuesta: D**

Várices. Insuficiencia venosa crónica

4.01.1.048 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Varices simples sin complicaciones: manejo inicial conservador con elevación de extremidades, ejercicio (caminata), control de peso y medias de compresión elástica. La cirugía/escleroterapia se reserva para cuando las medidas conservadoras fallan o hay complicaciones.

PREGUNTA 77 **Respuesta: A** **Cicatrices viciosas**

4.01.1.057 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cicatrices viciosas" (4.01.1.057), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 78 **Respuesta: A** **Hemorragia digestiva alta**

4.01.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hemorragia digestiva alta" como urgencia clínica (4.01.2.004), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 79 **Respuesta: C**

Perforación esofágica - Mediastinitis

4.01.2.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sospecha de perforación esofágica iatrogénica, con mediastinitis secundaria. El TAC es el mejor examen.

PREGUNTA 80 **Respuesta: A** **Traumatismos vasculares**

4.01.2.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismos vasculares" como urgencia clínica (4.01.2.023), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 81 **Respuesta: A** Septicemia

4.01.2.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Septicemia" como urgencia clínica (4.01.2.029), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 82 **Respuesta: A** Shock

4.01.2.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Shock" como urgencia clínica (4.01.2.031), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 83 **Respuesta: A**

Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia

4.01.2.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Paro cardiorespiratorio" como urgencia clínica (4.01.2.030), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 84 **Respuesta: C**

Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

4.01.2.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Indicar analgesia endovenosa

PREGUNTA 85 **Respuesta: D**

Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

4.01.2.028 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome Opioide: Este síndrome se caracteriza por compromiso de la conciencia, depresión respiratoria y miosis puntiforme (pupilas contraídas). Es importante diferenciarlo de otros síndromes: el síndrome por benzodiazepinas también presenta compromiso de conciencia y depresión respiratoria, pero sin alteración pupilar significativa; los síndromes adrenérgico y anticolinérgico causan midriasis (pupilas dilatadas); y el síndrome colinérgico, al igual que el opioide, se caracteriza por miosis (pupilas contraídas).

PREGUNTA 86 **Respuesta: A**

Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)

4.01.2.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

[Pregunta disputada] Es una pregunta difícil, ya que el compromiso hemodinámico y los signos peritoneales pueden corresponder tanto a un hemoperitoneo, como a la dehiscencia de la base apendicular. Sin embargo, por predominar el compromiso hemodinámico, nos inclinamos a marcar hemoperitoneo. Si, en cambio, hubiese tenido predominancia de los signos peritoneales, nos habríamos inclinado a la dehiscencia.

PREGUNTA 87 **Respuesta: D**

Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

4.01.2.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Si bien también se puede afrontar con punto separado, en pediatría y también en adultos, se prefiere la sutura intradérmica para las heridas grandes de la cara, por su mejor resultado estético.

PREGUNTA 88 **Respuesta: A**

Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

4.01.2.025 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Heridas y contusiones menores" como urgencia clínica (4.01.2.025), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 89 **Respuesta: E**

Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones

4.01.2.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Un tumor pulsátil en esa zona, hace pensar en un AAA.

PREGUNTA 90 **Respuesta: A**

Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

4.01.2.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Trauma" como urgencia clínica (4.01.2.027), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.
